



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

TERM OF REFERENCE (TOR)
PELATIHAN PPI DASAR
2026

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



**TOR Pelatihan PPI Dasar
RS Prima Husada Malang
Tahun 2026**

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Health Care-Associated Infections (HAIs) atau Infeksi Terkait Pelayanan Kesehatan (ITPK) merupakan salah satu masalah penting dalam keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan. HAIs dapat terjadi pada pasien selama mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan dapat berdampak terhadap pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, maupun sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa HAIs merupakan salah satu kejadian tidak diharapkan yang paling sering terjadi dalam pemberian pelayanan kesehatan dan tidak ada negara maupun sistem kesehatan yang dapat menyatakan terbebas dari HAIs.

Berdasarkan Global Report on Infection Prevention and Control 2024, WHO memperkirakan bahwa dari setiap 100 pasien yang dirawat di rumah sakit akut, sekitar 7 pasien di negara berpendapatan tinggi dan 15 pasien di negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs) mengalami sedikitnya satu HAIs selama masa perawatan. Dengan demikian, angka 15% tersebut dapat digunakan sebagai gambaran beban HAIs pada kelompok negara yang mencakup Indonesia, namun bukan merupakan angka prevalensi khusus Indonesia.

HAIs dapat menyebabkan berbagai dampak terhadap keselamatan dan hasil pelayanan pasien, antara lain memperpanjang lama rawat, meningkatkan kebutuhan penggunaan obat dan tindakan medis, meningkatkan biaya pelayanan, meningkatkan risiko resistansi antimikroba (AMR), menyebabkan kecacatan, serta meningkatkan risiko kematian. WHO juga melaporkan bahwa sekitar 1 dari 10 pasien yang mengalami HAIs meninggal akibat infeksi, sedangkan pasien di ruang intensif dan bayi baru lahir merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi.

HAIs juga memiliki keterkaitan yang erat dengan antimicrobial resistance (AMR). Infeksi yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang resisten terhadap antimikroba sehingga semakin sulit ditangani. Oleh karena itu, pencegahan HAIs tidak hanya merupakan bagian dari keselamatan pasien, tetapi juga merupakan salah satu strategi penting dalam pengendalian resistansi antimikroba.

Di Indonesia, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan menetapkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan program PPI untuk mencegah dan meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan juga telah mengembangkan sistem pelaporan surveilans HAIs melalui aplikasi SIMAR (Sistem Informasi Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit) untuk meningkatkan ketersediaan data HAIs dan mendukung pembinaan serta pengawasan mutu pelayanan.

Perkembangan sistem pelaporan tersebut menunjukkan bahwa penguatan surveilans HAIs di Indonesia masih menjadi prioritas. Pada periode Desember 2023–



Februari 2024, tingkat kepatuhan pelaporan HAIs rumah sakit melalui sistem Kementerian Kesehatan meningkat dari 31,0% pada Desember 2023 menjadi 44,9% pada Februari 2024. Selanjutnya, berdasarkan data per 17 Juni 2024, sebanyak 1.623 rumah sakit atau 48,7% telah melakukan pelaporan HAIs. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelaporan, namun sekaligus menunjukkan bahwa cakupan pelaporan nasional masih perlu diperkuat agar data HAIs Indonesia dapat semakin lengkap dan representatif.

Dalam perkembangan terbaru, WHO bersama Kementerian Kesehatan juga melakukan penilaian terhadap implementasi PPI di rumah sakit Indonesia pada 18 November–11 Desember 2024. Hasil penilaian menunjukkan bahwa 80% rumah sakit yang dinilai mencapai kinerja tingkat lanjut pada sedikitnya lima dari delapan komponen inti PPI. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam implementasi PPI di Indonesia, namun penguatan kompetensi petugas, pelatihan berkelanjutan, surveilans, penerapan kewaspadaan isolasi, kepatuhan kebersihan tangan, penerapan bundle HAIs, serta monitoring dan evaluasi tetap diperlukan.

WHO juga menekankan bahwa sebagian besar HAIs dapat dicegah melalui penerapan PPI yang efektif, termasuk kebersihan tangan, kewaspadaan standar dan transmisi, keamanan injeksi, pencegahan infeksi daerah operasi, pencegahan infeksi terkait penggunaan alat invasif, pengelolaan lingkungan, serta ketersediaan air, sanitasi dan higiene yang memadai. Program PPI yang baik terbukti dapat memberikan dampak besar dalam menurunkan kejadian infeksi yang sebenarnya dapat dicegah.

Sejalan dengan hal tersebut, WHO pada tahun 2024 menerbitkan *Surveillance of Health Care-Associated Infections at National and Facility Levels*, yang memberikan pendekatan terbaru untuk pelaksanaan surveilans HAIs, termasuk definisi kasus yang disederhanakan dan divalidasi untuk membantu fasilitas pelayanan kesehatan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan perbandingan data HAIs secara lebih konsisten.

Oleh karena itu, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi harus menjadi tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang terlibat dalam pelayanan, bukan hanya menjadi tanggung jawab Komite/Tim PPI. Pengetahuan dan keterampilan mengenai epidemiologi HAIs, kewaspadaan isolasi, kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, pencegahan infeksi terkait tindakan dan alat kesehatan, surveilans HAIs, bundle HAIs, ICRA PPI, serta monitoring dan audit PPI perlu diberikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada seluruh staf rumah sakit.

Salah satu strategi untuk meningkatkan kompetensi tersebut adalah melalui Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Dasar bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. Kementerian Kesehatan pada kurikulum pelatihan PPI Dasar tahun 2024 menetapkan kompetensi yang mencakup epidemiologi HAIs, penemuan kasus HAIs, kewaspadaan isolasi, mikrobiologi dan virologi dasar, ICRA PPI, surveilans HAIs, pencegahan dan pengendalian infeksi melalui bundle HAIs, serta monitoring dan audit program PPI.

Dengan dilaksanakannya pelatihan PPI secara terencana dan berkelanjutan, diharapkan seluruh staf rumah sakit memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai dalam menerapkan prinsip PPI pada setiap proses pelayanan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan risiko HAIs yang dapat dicegah, meningkatkan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, mendukung pengendalian resistansi antimikroba, serta meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan di rumah sakit.



1.2 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit.
- f. Pedoman dan publikasi WHO terkait Infection Prevention and Control (IPC) dan Health Care-Associated Infections (HAIs), khususnya:
WHO. Global Report on Infection Prevention and Control 2024.
WHO. Surveillance of Health Care-Associated Infections at National and Facility Levels: Practical Handbook, 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tenaga kesehatan serta staf rumah sakit dalam menerapkan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) secara tepat dan konsisten dalam setiap proses pelayanan kesehatan guna mencegah dan menurunkan risiko terjadinya Health Care-Associated Infections (HAIs).

B. Tujuan

a) Tujuan Umum

Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan prinsip, program, serta prosedur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien, keselamatan petugas, dan mutu pelayanan.

b) Tujuan Khusus

Setelah mengikuti pelatihan, peserta diharapkan mampu:

- a. Dipahaminya pengertian, tujuan, program, dan prosedur PPI yang berlaku di RS.
- b. Dipahaminya pengertian Handhygiene, penurunan risiko infeksi, penggunaan APD, dan penempatan pasien berdasar kewaspadaan tranmisi.
- c. Dipahaminya pencegahan HAIs dengan bundles serta pengendalian lingkungan.
- d. Dipahaminya tata cara penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh dengan spillkit.
- e. Dilaksanakannya 6 langkah kebersihan tangan dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan kebersihan tangan sesuai prinsip Five Moments for Hand Hygiene dan penggunaan alat pelindung diri.



II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 SUSUNAN PANITIA

No	Susunan Panitia	Nama	Tugas
1	Ketua Panitia	Lusianah Nurul I, AMd. Kep	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara. Hasil akhir : LPJ
2	Sekretaris	Laras Wienny Nuriska, AMd. Kep	Bertanggung jawab terhadap pendokumentasian seluruh dokumen dan notulen.
3	Moderator	Tri Ani Darma Wanti, AMd. Kep	Bertanggung jawab memimpin jalannya acara pelatihan (sesi materi, diskusi, tanya jawab), pengkondisian peserta.
4	Absensi	Laras Wienny Nuriska, AMd. Kep	Bertanggung jawab tentang link/ memastikan kehadiran para peserta pelatihan.
5	Sie Dokumentasi	Neni novitasari, AMd. Kep	Bertanggung jawab sebagai fotografer.
6	Sie Perlengkapan	Erik Ardiananta, Tri Ani Darma Wanti, AMd. Kep	Bertanggung jawab terhadap kelengkapan peralatan, peminjaman, dan pengembalian alat. Mengambilkan alat-alat yang belum tersedia saat acara.
7	Sie Penunjang	Susan Rahmawati, S.Sos	Bertanggung jawab mengkoordinir peserta untuk patuh dengan jadwal pelatihan.
8	Sie Pretest dan Posttest	Neni novitasari, AMd. Kep	Bertanggung jawab menyiapkan, membagikan dan merekap hasil pre dan post test.

2.2 RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Pelatihan PPI Dasar Seluruh staf RS Prima Husada Malang Tahun 2026 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

- Tanggal : Rabu, 2 September 2026
Kamis, 3 September 2026
- Pukul :
Rabu, 2 September 2026: Gelombang I : 08.30 s/d 10.00 WIB
Gelombang II: 13.30 s/d 15.00 WIB
Kamis, 3 September 2026: Gelombang I : 08.30 s/d 10.00 WIB
Gelombang II: 13.30 s/d 15.00 WIB
- Tempat : Hall Sakura Lantai 5A RS Prima Husada Malang

2.3 RENCANA RAPAT PANITIA PENYELENGGARAAN

Judul Materi	Sasaran	Narasumber	Metode	Perlengkapan	Frekuensi Pelaksanaan	Dasar Materi	Output Training	Target Training Jangka Panjang
Pelatihan PPI Dasar	1. Seluruh Staf RS Prima Husada Malang	1) Lusianah Nurul I, AMd. Kep 2) Tri Ani Darm a Wanti, AMd. Kep 3) Laras Wienn y Nuriska, AMd. Kep	a. Pre-Post Test b. Presentasi c. Diskusi d. Tanya Jawab e. Praktik	a. LCD b. Laptop c. Sound system d. Platform	Selama 2 hari (2 – 3 September 2026), dalam sehari ada 2 Gelombang (Pagi dan Siang)	Materi dan praktik: 1. Konsep dasar HAIs 2. Rantai Penularan Infeksi 3. Program PPI 4. Kewaspadaan Isolasi: a. Kewaspadaan standar: - Pengkajian Risiko - <i>Hand Hygiene</i> (praktik) - Etika Batuk (praktik) - Penempatan Pasien - APD - Teknik Aseptik - Penyuntikan yang Aman & Pajanan - Pengendalian Lingkungan (praktik spill kit) - Penanganan Linen & Laundry - Pengelolaan limbah - Dekontaminasi & pemrosesan alat b. Kewaspadaan transmisi: - Kewaspadaan kontak - Kewaspadaan droplet - Kewaspadaan airborne	a. Memahami langkah– langkah Handhygiene, five momen, penurunan risiko infeksi, pengunaan APD, penempatan pasien berdasar kewaspadaan tranmisi. b. Dipahaminya pencegahan HAIs dengan bundles serta pengendalian lingkungan. c. Peserta dapat memahami tata cara penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh dengan spillkit. d. Peserta memahami indicator dan pelaporan PPI e. Peserta memahami alur pengelolaan (alat medis/laundry/limbah/ pembersihan lingkungan) yang aman.	1. Peningkatan kepatuhan PPI di unit kerja 2. Penurunan risiko transmisi infeksi 3. Penerapan isolasi sesuai risiko 4. Kepatuhan terhadap SPO dan pengendalian risiko lingkungan 5. Perbaikan berkelanjutan melalui audit/supervisi dan RTL

Outline Training

No	Outline	Isi PPT	PJ
1	Barcode absensi	QR code absensi	MC
2	Pre test	QR code pre test dengan waktu (estimasi 30 detik / pertanyaan)	MC
3	Susunan acara	Tabel rundown acara training	MC
4	Judul	Pelatihan PPI Dasar	Narsum
5	Latar Belakang	Health Care Associated Infection (HAIs) atau Infeksi sehubungan dengan pelayanan kesehatan merupakan masalah serius bagi semua sarana pelayanan kesehatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kejadian infeksi ini dapat menghambat proses penyembuhan dan pemulihan pasien serta menurunkan mutu pelayanan fasyankes. Untuk mencapai program PPI dengan baik dan benar perlu mengadakan pelatihan Pencegahan Pengendalian Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan kepada seluruh staf rumah sakit.	Narsum
6	Target	Setelah mengikuti materi ini peserta dapat menjelaskan tentang PPI dengan benar. Peserta dapat menjelaskan pengertian, tujuan, konsep dasar HAI's, rantai penularan penyakit, dan kewaspadaan isolasi Peserta mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip dasar PPI pada pelayanan sehari-hari terutama di lingkungan RS	Narsum
7	Materi	Materi dan praktik: 1. Konsep dasar HAIs 2. Rantai Penularan Infeksi 3. Program PPI 4. Kewaspadaan Isolasi: 5. Kewaspadaan standar: a) Pengkajian Risiko b) <i>Hand Hygiene</i> (praktik) c) Etika Batuk (praktik) d) Penempatan Pasien e) APD f) Teknik Aseptik g) Penyuntikan yang Aman & Pajanan h) Pengendalian Lingkungan (praktik spill kit) i) Penanganan Linen & Laundry	Narsum

		j) Pengelolaan limbah k) Dekontaminasi & pemrosesan alat 6. Kewaspadaan transmisi: - Kewaspadaan kontak - Kewaspadaan droplet - Kewaspadaan airborne	
12	Kesimpulan	- Pencegahan dan Pengendalian Infeksi atau HAIs harus dilaksanakan setiap saat, dimanapun, kapanpun oleh siapapun memberikan layanan kesehatan. - Program PPI meliputi pendidikan dan pelatihan Kewaspadaan Isolasi, Pencegahan Infeksi pada pemasangan alat kesehatan, kegiatan surveilans, serta penggunaan antimikroba rasional - Keberhasilan PPI harus ada dukungan manajemen, keterlibatan dan komitmen seluruh staf.	MC
13	Post Test	QR code post test	MC

Rapat : Pre Training : Materi/ Bahasan Alur Persiapan dan Pelaksanaan Training

No	Langkah	PJ	Yang terlibat
Pre Training			
1	Mendiskusikan materi yang akan diberikan untuk training (materi berdasarkan outline training)	Tim PPI	SDM, Komite PPI Narasumber
2	Pembuatan soal pre/post test & kunci jawaban	Tim PPI/SDM	
3	Pembuatan PPT berdasarkan materi yang sudah didiskusikan	Narasumber	Tim PPI
4	Pengumpulan PPT materi maksimal H-7 acara	SDM	Narasumber
5	Menentukan moderator training	SDM	Tim PPI
6	Menyusun panitia (MC merangkap dokumentasi, IT sebagai operator)	SDM	Panitia
7	Membuat / membahas Form Evaluasi penyelenggara untuk narasumber	SDM	Tim PPI
8	Media apa saja yang perlu disiapkan agar diklat berjalan sesuai tujuan dan harapan	Tim PPI	Perlengkapan
9	Penyusunan slide host (PPT yang ditampilkan sejak awal mulai dari absensi, pre test, rundown, ppt materi, post test dijadikan 1 kesatuan)	IT/SDM	MC, Narasumber

2.4 SASARAN ATAU PESERTA

No	Profesi	Jumlah
1	PT	21
2	Manajemen	11
3	Dokter	8
4	Perawat	138
5	Bidan	18
6	Farmasi	40
7	Gizi/dapur	16
8	Radiografer	6
9	Laborat	9
10	Rehab Medik	6
11	RM/Pdf	19
12	Asuransi center/kasir	18
13	CSSD/Laundry	8
14	IPSRs/SIMRS	9
15	UMUM/CS/Driver/	60
16	PIPP	4
17	MS	39
TOTAL		430

2.5 SUSUNAN ACARA LENGKAP

Rundown kegiatan

Jam	Durasi	Materi	Pemateri
Gelombang I			
08.30 - 08.35	5 menit	Absensi	Tim
08.35 - 08.45	10 menit	Pre test	Tim
08.45 - 09.45	60 menit	Materi dan demonstrasi: - Konsep dasar HAIs - Rantai Penularan Infeksi - Program PPI - Kewaspadaan Isolasi: - Kewaspadaan standar: - Pengkajian Risiko <i>Hand Hygiene</i> (praktik) - Etika Batuk (praktik) - Penempatan Pasien - APD - Teknik Aseptik - Penyuntikan yang Aman & Pajanan - Pengendalian Lingkungan (praktik spill kit) - Penanganan Linen & Laundry - Pengelolaan limbah - Dekontaminasi & pemrosesan alat - Kewaspadaan transmisi: - Kewaspadaan kontak - Kewaspadaan droplet Kewaspadaan airborne	- Lusianah Nurul I, AMd. Kep - Tri Ani Darma Wanti, AMd. Kep - Laras Wienny Nuriska, AMd. Kep
09.45 - 09.50	5 menit	Tanya Jawab	Tim
09.50 - 10.00	10 menit	Post test	Tim
Gelombang II			
13.30 - 13.35	5 menit	Absensi	Tim



13.35 - 13.45	10 menit	Pre test	Tim
13.45 - 14.45	60 menit	Materi dan praktik: 5. Konsep dasar HAIs 6. Rantai Penularan Infeksi 7. Program PPI 8. Kewaspadaan Isolasi: c. Kewaspadaan standar: - Pengkajian Risiko - <i>Hand Hygiene</i> (praktik) - Etika Batuk (praktik) - Penempatan Pasien - APD - Teknik Aseptik - Penyuntikan yang Aman & Pajanan - Pengendalian Lingkungan (praktik spill kit) - Penanganan Linen & Laundry - Pengelolaan limbah - Dekontaminasi & pemrosesan alat d. Kewaspadaan transmisi: - Kewaspadaan kontak - Kewaspadaan droplet Kewaspadaan airborne	1. Lusianah Nurul I, AMd. Kep 2. Tri Ani Dharma Wanti, AMd. Kep 3. Laras Wienny Nuriska, AMd. Kep
14.45 - 14.50	5 menit	Tanya Jawab	Tim
14.50 - 15.00	10 menit	Post test	Tim

2.6 NARASUMBER

1. Lusianah Nurul I, AMd. Kep
2. Tri Ani Dharma Wanti, AMd. Kep
3. Laras Wienny Nuriska, AMd. Kep

2.7 MEDIA

- a) LCD
- b) Laptop
- c) Sound system
- d) Platform

2.8 METODE

- 1) Pre-Post Test
- 2) Presentasi
- 3) Diskusi
- 4) Tanya Jawab
- 5) Praktik

2.9 KEBUTUHAN ANGGARAN

No.	Rincian Kebutuhan	Jumlah	Satuan (Rp)	Harga (Rp)	Sumber Dana
Rabu, 2 September 2026					
1	Konsumsi Pemateri	1 kotak	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-	Dapur RSPHM
2	Snack Panitia	2 kotak	Rp 5.000,-	Rp 10.000,-	Dapur RSPHM
3	Air minum	3 dus	Rp 30.000,-	Rp 90.000,-	Dapur RSPHM



4	Handscoon non steril size S (100 pcs/ box)	1 box	Rp 0	Rp 0	Gudang Farmasi
5	Pewarna makanan	1	Rp 0	Rp 0	Gudang Umum
6	Sertifikat	215	Rp 0	Rp 0	Internal Cetak Soft copy
Kamis, 3 September 2026					
1	Konsumsi Pemateri	1 kotak	Rp 20.000,-	Rp 20.000,-	Dapur RSPHM
2	Snack Panitia	2 kotak	Rp 5.000,-	Rp 10.000,-	Dapur RSPHM
3	Air minum	3 dus	Rp 30.000,-	Rp 90.000,-	Dapur RSPHM
4	Handscoon non steril size S (100 pcs/ box)	1 box	Rp 0	Rp 0	Gudang Farmasi
5	Pewarna makanan	1	Rp 0	Rp 0	Gudang Umum
6	Sertifikat	215	Rp 0	Rp 0	Internal Cetak Soft copy
Total				Rp 240.000,-	
Yang diajukan kepada PT Disa Prima Medika				Rp 240.000,-	

III. MONITORING – EVALUASI

3.1 MONITORING

No	Bahasan dan kegiatan	PJ	Yang Terlibat/ yang Masuk Panitia
1	Memastikan training berjalan sesuai TOR dan rundown	SDM	PJ Training
2	Mencatat evaluasi yang ditemukan selama training berjalan	SDM	PJ Training
3	Memimpin evaluasi setelah training selesai	SDM	PJ Training
4	Mengirimkan link g-form evaluasi yang diisi oleh narasumber	SDM	Narasumber
5	Menyiapkan kredensial apabila materi training ada sesi praktek / role play	SDM	Ketua Komite PPI

3.2 EVALUASI

Evaluasi (Post Training) Jangka Pendek			
1	Merekapitulasi hasil nilai pre test dan post test	Neni novitasari, AMd. Kep	Panitia
2	Melakukan evaluasi hasil penilaian baik untuk penyelenggara maupun untuk narasumber dan pengamatan perilaku peserta saat diklat (serius, mengantuk, antusias)	Neni novitasari, AMd. Kep	Panitia
3	Menerbitkan sertifikat	SDM	SDM
4	Evaluasi kinerja panitia	SDM	SDM



Evaluasi (Post Training) Jangka Panjang			
1	Melakukan supervisi atau observasi kepatuhan peserta diklat terhadap regulasi dan materi-materi dalam diklat yang sudah diikuti	Lusianah Nurul I, AMd.Kep	SDM dan Tim Komite PPI
2	Hasil supervisi dibahas di rapat koordinasi	Lusianah Nurul I, AMd.Kep	Tim Komite PPI
3	Membuat RTL-TL-Evaluasi secara berkala	Lusianah Nurul I, AMd.Kep	Tim Komite PPI

IV. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Untuk mempertahankan nilai Akreditasi Rumah Sakit meraih Paripurna. Oleh karena itu dukungan semua pihak sangat penting dalam keberhasilan acara ini.

Mengetahui,
SDM RS Prima Husada Malang

Susan Rahmawati, S.Sos

Malang, 10 Agustus 2026
Ketua Panitia,

Lusianah Nurul I, AMd.Kep

Disetujui oleh,
Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes